



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : هند محمد احمد محمد
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : العجوزه
رقم البطاقة : 28402182104023 رقم التليفون : 01150794884
العمر (تاريخ الميلاد) : 18-02-1984 المهنة : ربه منزل
العنوان : قسطل - شارع 17
تاريخ تسجيل الإستماره : 27-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----
قسم : -----
نفقات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هند محمد احمد محمد National ID: 28402182104023	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

(-----) : (التي قافية)
المعنى
في حالة ثبوت غير ذلك
العلاج في حالات بقاء داء الحلق وسوء حاله والاولى - الدوا للبقاء على علاج الامام نظام بهما من يتعامل مع نظام آخر انا للمؤلف ان شاء الله تعالى

١٢٨

اسم المريض: رضا علي هدا محمد احمد محمد الحى / المدنية: الجوزة
رقم المنطقة: 28402182104023 رقم التسجيل: 01150794884 المهنة: ربه ميرل
التاريخ: 18-02-1984 (تاريخ الميلاد): 18-02-1984 العمر: 34

* (EPE) مصر - البتري بانشيتو بالي جوسيف روسوف جوسيف



Name: هند محمد احمد محمد MR. : 4077		
Detailed Medical Report		
السيد		
تحية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	
إيماء للطلب المقدم من		
	رقم طبي:	
بقسم:		
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	
تاريخ وساعة الدخول :		
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
Patient is receiving a combination of affinitor, aromasin, and Zoladex (3 month course), with Zoladex administered today. CT CAP assessment after 3 months of affinitor/aromasine (1 Dec 2025) shows stable disease. The patient presented today for continuation of afinitor and aromasin; the last CT CAP was 1 Dec 2025 and demonstrated stable disease; laboratory values are within normal limits. Denovo metastatic breast cancer to the liver was diagnosed in May 2023. The patient received AI + Zoladex for 6 months, followed by docetaxel (DP). Subsequently, 6 months of fulvestrant (Faslodex) + Ibrance were administered, then 9 cycles of docetaxel (TXT) with stable disease. The regimen was shifted to aromasin + affinitor in March 2025. A CT CAP in April 2026 revealed progressive disease of the 4.5 cm HFL segment VIII, prompting a multidisciplinary tumor board discussion on 16 Apr 2026. Biopsy of the HFL lesion was planned, and Xeloda was started pending approval. For Xeloda, supportive care was planned with the next visit after 21 days; weight 86 kg, height 164 cm. The dose schedule of 3 × 2 × 14 was initiated, with monitoring of CBC and liver function tests. On 7 Jun 2026, the patient received Xeloda 3 × 3 × 14; a liver biopsy of the HFL lesion was performed. Endocrine receptor status was ER 8/8, HER2 0. After consultation with Dr. Shimaa Lasheen, Xeloda therapy was continued with close follow-up.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	
التاريخ :		
20-09-2026		
الطبيب المعالج :		
ندى حسن صلاح كامل		
يعتمد ,		

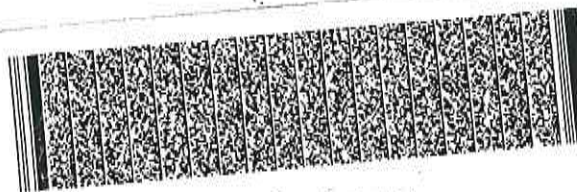
KD9084789

٢٩٨٤/٠٣٧٩٨



٣٨٠٣٠١٨٧١٨٠٣٧٨
١٧ شى السودان-سائى الاموال
مجدد احمد محمد
فيل

بطاقة هوية الشخصية
٢٩٨٤/٠٣٧٩٨



٢٠٣٣/٠٩
٧٨٤٠١٨٧١٨٠٣٧٨
حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية
إبش
مستلمة
٢٠٣٣/٠٩
١٠/٩/٢٠٣٣
الطاقة سارية حتى



اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

تقرير طبي

السيد/

تحتية طبية وبعد،،

بشان تقرير طبي للمريض: د. محمد سعيد أحمد ك

رقم طبي

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته:

تاريخ وساعة الخروج

تاريخ وساعة الدخول

ويط الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

CPt usgr IDC CTII عPR 518 PR 018 H20
(5-2023) Demar MBC to حسا → received AL + Zolad

for bonark → DP

for Slader, Ibranc → DP

Text * cyclo → SID

Shifted to aremadin 2 adonam sunsals (2025)

CT CAP (u. 2016) → DP

(5-2026) . Bx for HPL (ERSLS PR 018 Hmo

CT CAP (8-2026) → DP of HPL

تحريراً في

التاريخ: / /

الوقت:

الطبيب المعالج

for D-vulbone

يقطد،،

د. سجاد كز

644-9-9-2026

جولف
روغيني
أحمد محمدأحمد
أحمدمبادرة رئيس الجمهورية
لحجم صحة المرأة المصريةمستشفى
الجيزة
مصر

08/30/2026

0

MDT FORM

Name:	Hend Mohamed Ahmed Mohamed	MRN:	4077
Age:	43 Y	ID:	28402182104023
Menopausal Sta	pre	Phone:	01150794884
NRS SCORE:		Marital Status:	married
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:	-ve	Reason Of MDT:	mbc

Clinical Data:

BX:

R

L

ER: 5/8 PR: 0/8 HER2: 0 KI67:

Sonomammography:

Mets Workup:

History:

5/2023 >> DENOVO MBC TO LIVER >> RECEIVED AI + ZOLADEX FOR 6 MO
THEN DP >> THEN RECEIVED 6 MO OF FASLODEX + IBRANCE >> DP
THEN RECEIVED TXT 9 CYCLES >> SD
THEN SHIFTED TO AROMASINE + AFFINITOR SINCE 3/2025
CT CAP 4/2026 >> PD OF HFL
5/2026 hfl bx: met breast origin (er 8/8, pr 0/8, her2 0)
16/4/2026 Xeloda *3 cycles

TNM

8/2026 CT cap: pd in hfl +breast mass

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

for navelbine single agent

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
أحمد محمد	أحمد محمد				



4.2.2

Patient's Name:

Hind Mohammed Ahmed Mohammed

Date:

2026-08-06

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

MULTISLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS AFTER ORAL AND I.V. CONTRAST INJECTION REVEALED:

Compare to previous study dated 5/4/2026. the current study dated

I- CHEST:

- progressive course of the left breast mass lesion measuring 28 x 28 mm with overlying thickened skin compare to 27x17mm at the previous study
- No pulmonary nodules or masses
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No dilated biliary radicles. Multiple hepatic hypodense focal lesions the largest is seen in the left lobe measuring 47x 30 mm showed heterogenous mainly peripheral enhancement compare to the largest one at the previous study seen at segment VIII measuring 45x20mm
- Both kidneys are normal size, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.



Patient's Name:

Hind Mohammed Ahmed Mohammed

Date:

2026-08-06

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

- Still seen multiple scatterd vertebral and bilateral iliac bones sclerotic lesions

Opinion:

- ❖ Progressive course of the left breast mass lesions.
- ❖ Progressive course of the hepatic metastatic lesions.
- ❖ Stationary rest of study

Dr.Asser Ahmed

Dr.Asser Ahmed

Patient Name
Sex/Age
Registered Date
Validation Date
Reporting Date

803	من مريض احمد محمد فرال
Female 42Y	
23/05/2026 12:36:53	
01/06/2026 15:13:29	
6/7/2026, 1:50:44 PM	

Code Number
Patient ID
Referred By Dr.
Branch

YK 262886
20089
Out Patient
Gustave Roussy

Hepatic focal lesion

Pathology report

Clinical Data: Multiple hepatic lobe focal lesions, in known case of managed breast cancer.

Nature of Specimen: Hepatic lobe focal lesion, Tru-cut biopsy, collected on 23/05/2026, cold ischemia time: 20 seconds.

Gross Examination:

- Fragmented grey white tissue cores, ranging in size between 0.2 cm & 1.2 cm long. Totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), Ki67 clone (30-9) & GATA3 (L50-823).

Microscopic Examination:

* Histopathological examination reveals cores of hepatic tissue showing infiltration by tumor formed of malignant epithelial cells showing moderate nuclear pleomorphism and eosinophilic cytoplasm, arranged in clusters with poor tendency to tubular formation amid desmoplastic stroma.

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- GATA3: Positive staining in tumor cells.
- ER: Moderate nuclear staining in 90% of tumor cells (score 8/8).
- PR: No nuclear staining in tumor cells (score 0/8).
- Her2: Negative (score 0).

Diagnosis:

Hepatic lobe focal lesion, Tru-cut biopsy:

Findings are consistent with metastatic carcinoma of breast origin.

IPT:

- GATA3: Positive.
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- Her2: Negative (score 0).

** Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%

and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

***Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

Patient Name
Sex/Age
Registered Date
Validation Date
Reporting Date

803	مينا محمد احمد محمد فرار
Female 42Y	
23/05/2026 12:36:53	
01/06/2026 15:13:29	
6/7/2026, 1:50:44 PM	

Code Number
Patient ID
Referred By Dr.
Branch

YK 262886
20089
Out Patient
Gustave Roussy

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr. Maha Guimei

Liver Function

:

{



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة 5 - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mistr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient's Name:

hend mohamed ahmed mohamed

Date:

2026-04-05

Referred by:

Prof.Dr. ct cap iv

Hospital:

Goustave Rousseau International Egypt

MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

TECHNIQUE: Multislice axial CT images of the chest, abdomen and pelvis obtained from the lower neck to the symphysis pubis with multiplanar reconstruction. IV contrast was used.

FINDINGS:

Clinically reported left breast carcinoma compared to last study dated 1/12/2025.

(I) Chest:

- ☐ Left breast mass LOQ measures 2.7 x 1.7 cm with bilateral skin thickening.
- ☐ Clear both lung fields .no sizable pulmonary masses or consolidation patches
- ☐ few enlarged mediastinal lymph node , .
- ☐ No pleural or pericardial collections seen.
- ☐ No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- ☐ The liver is enlarged in size showing progressive course regarding bilobar heterogeneously enhancing hepatic focal lesions , with the largest seen at segment VIII measures 4.5 x 2 cm
- ☐ Patent and homogenously enhancing portal vein.
- ☐ No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- ☐ Normal CT appearance of the pancreas, both kidneys, aorta and IVC.

Patient's Name:

hend mohamed ahmed mohamed

Date:

2026-04-05

Referred by:

Prof.Dr. ct cap iv

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

- ☐ Normal CT appearance of the spleen with small splenule 13 x 13 mm .
- ☐ Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses .
- ☐ Unremarkable other pelvic organs.
- ☐ No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- ☐ No ascites.
- ☐ Stationary course regarding scattered axial and appendicular skeleton sclerotic lesions
- ☐ No vertebral structural collapse .

OPINION:

- progressive course regarding bilobar heterogeneously enhancing hepatic focal lesions.
- Rather stationary rest of the study .

Dr.Reham Khedr, MD